

Ensayo Profesional: La Historia Clínica en Colombia y su Rol Crítico en la Facturación de Servicios de Salud

Introducción

La historia clínica, como instrumento técnico, ético y legal, representa uno de los elementos más sensibles del sistema de salud colombiano. No solo cumple una función asistencial para documentar el estado de salud del paciente y el proceso terapéutico, sino que también cumple una función **legal-administrativa clave para el soporte de la facturación**, auditoría de servicios y vigilancia del gasto en salud. Su adecuada diligencia, custodia y uso garantizan la transparencia del proceso contractual entre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), asegurando la sostenibilidad financiera y la protección de los derechos fundamentales de los usuarios. En este ensayo se presenta un análisis detallado del papel de la historia clínica en la estructuración y clasificación del proceso de facturación, su marco normativo, su relación con los distintos tipos de contratación, y las consecuencias legales y éticas de su mal manejo.

Contexto Histórico y Marco Normativo

La evolución de la historia clínica en Colombia está estrechamente ligada al desarrollo institucional del sistema de salud. Inicialmente concebida como una herramienta clínica de uso interno, su importancia se formalizó con la **Ley 23 de 1981**, que estableció que todo acto médico debe quedar debidamente registrado, convirtiendo la historia clínica en un documento de carácter obligatorio, confidencial y sujeto a control legal.

La transformación del sistema de salud con la **Ley 100 de 1993** significó un cambio de paradigma: el sistema pasó de ser centralizado a un modelo mixto basado en aseguramiento. Esto hizo indispensable contar con documentos verificables que demostraran la prestación efectiva de los servicios. La **Resolución 1995 de 1999**, expedida por el Ministerio de Salud, definió con claridad los contenidos mínimos de la historia clínica, su tiempo de conservación (15 años), y estableció parámetros técnicos para su custodia y acceso.

El avance hacia la interoperabilidad y la digitalización ha sido reforzado por normas como la **Ley 1751 de 2015** (Estatutaria de Salud), que reconoce la salud como un derecho fundamental y consagra el acceso a la información clínica como una garantía de ese derecho, y la **Resolución 3100 de 2019**, que define condiciones para la habilitación de los servicios de salud, incluyendo la obligación de gestionar adecuadamente la historia clínica, ahora también en formato electrónico.

Importancia de la Historia Clínica en la Facturación por Tipo de Contratación

1. Contratación por Capitación

En este modelo, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) pagan a las IPS una suma fija por cada afiliado, independientemente del uso real de los servicios. Aun cuando no se genera una factura por cada atención, la historia clínica adquiere una función clave al documentar la frecuencia, pertinencia y resultados de las atenciones brindadas. La historia clínica permite auditar los servicios efectivamente prestados frente a los recursos recibidos, aportando transparencia y trazabilidad.

2. Contratación por Evento

Este es el modelo más utilizado para facturar procedimientos, medicamentos, laboratorios, imágenes diagnósticas, entre otros. Cada ítem facturado debe estar plenamente sustentado con registros clínicos que incluyan motivo de consulta, diagnóstico, evolución, órdenes médicas, consentimiento informado y resultados. La ausencia de cualquiera de estos elementos puede resultar en **glosas administrativas**, lo que implica devoluciones, no pago o procesos de repetición financiera contra la IPS.

3. Pago Global Prospectivo (PGP)

El PGP combina anticipos financieros con compromisos de resultados. Aquí, la historia clínica debe mostrar el ciclo completo de atención, incluyendo seguimiento, intervenciones tempranas y cumplimiento de indicadores clínicos pactados. Es fundamental que la historia clínica refleje coherencia, continuidad y articulación de la atención para validar la correcta ejecución del presupuesto asignado.

4. Recobros a Terceros Pagadores (SOAT, ARL, ADRES, entre otros)

En estos casos, la historia clínica debe cumplir con estándares normativos específicos. Por ejemplo, para recobros por accidentes de tránsito (SOAT), es indispensable que la historia clínica documente el ingreso por urgencias, evolución, procedimientos, epicrisis y certificación del evento. En el caso de las ARL, se requiere además evidencia de la relación laboral, determinación del accidente o enfermedad laboral y soportes de incapacidad. La ausencia o inconsistencia en la historia clínica puede llevar al rechazo del recobro por parte del pagador.

Organización de Soportes Según la Entidad Responsable del Pago

Una historia clínica no estructurada o incompleta puede generar **glosas**, sanciones administrativas o incluso acciones legales. Por ello, es crucial organizar la documentación clínica según las exigencias de cada entidad responsable del pago:

- **EPS del Régimen Contributivo/Subsidiado:** Requieren historia clínica completa con autorización previa (cuando aplica), registros detallados de la atención, órdenes

médicas justificadas y medicamentos formulados conforme al Plan de Beneficios en Salud (PBS).

- **SOAT:** Exige historia clínica de urgencias, epicrisis, informe médico del evento, certificación del accidente, imágenes diagnósticas, y seguimiento clínico. Cada atención debe estar debidamente registrada y cronológicamente organizada.
- **ARL:** Además de la historia clínica, requiere certificaciones laborales, registro del evento en el sistema SIREL y relación de causa-efecto entre la actividad laboral y la patología.
- **ADRES y recobros no PBS:** Solicitan la historia clínica completa, soporte de negación por parte de la EPS, fórmula médica, conceptos técnicos y sentencia de tutela si aplica.

Consecuencias del Mal Manejo de la Historia Clínica

1. Responsabilidad Civil

Cuando una IPS o profesional de la salud no documenta adecuadamente una atención o realiza una mala práctica que no queda registrada, incurre en responsabilidad civil por daño antijurídico. El paciente afectado puede iniciar demandas patrimoniales contra el prestador, reclamando indemnizaciones por perjuicios ocasionados por la omisión, pérdida o falsedad en la historia clínica.

Además, si una factura es pagada con base en una historia clínica falsa o manipulada, se configura **cobro de lo no debido**, generando la obligación de **devolver los recursos** y sometiéndose a procesos sancionatorios por parte de entes de control.

2. Consecuencias Penales

La historia clínica, al tener carácter legal, está protegida por el Código Penal. Algunas conductas que pueden derivar en sanciones penales incluyen:

- **Falsedad en documento público o privado:** Registrar hechos que no ocurrieron o alterar información deliberadamente puede acarrear penas de prisión de 1 a 9 años.
- **Violación de datos personales o reserva legal:** Acceder, divulgar o compartir historia clínica sin consentimiento expreso del paciente puede derivar en delitos contra la privacidad, conforme al artículo 269F del Código Penal y la Ley 1581 de 2012.

3. Sanciones Administrativas y Disciplinarias

Las IPS están sujetas a la vigilancia de la **Superintendencia Nacional de Salud**, la cual puede imponer sanciones que incluyen:

- Multas de hasta 8.000 salarios mínimos por alteración, pérdida o falta de registros clínicos.
- Suspensión de servicios o de la habilitación.
- Cierre de la institución en casos de reincidencia o daño sistemático.

Además, los profesionales de la salud pueden ser sancionados por los tribunales de ética médica con **suspensión de la tarjeta profesional**.

4. Violación de Derechos Fundamentales

La historia clínica protege el **derecho a la intimidad**, el **derecho a la salud** y el **derecho a la información veraz**. Su pérdida, manipulación o divulgación indebida constituye una violación grave a los derechos fundamentales. Los pacientes pueden interponer **acciones de tutela**, demandar por vía constitucional, o denunciar ante la **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)** por violaciones a la Ley de Habeas Data.

Otras Consecuencias Críticas

1. Pérdida de Credibilidad Institucional

La credibilidad de una IPS depende, en gran medida, de la calidad y transparencia de sus registros clínicos. Una historia clínica mal diligenciada, incompleta o incoherente genera desconfianza por parte de:

- Entidades pagadoras (EPS, aseguradoras).
- Entes de control (SuperSalud, Minsalud).
- Usuarios y comunidad en general.

Esto puede traducirse en terminación de contratos, exclusión de redes de prestadores y pérdida de pacientes.

2. Dificultades en Auditorías y Supervisiones

La historia clínica es el insumo principal para las auditorías internas, externas, clínicas y financieras. La carencia de información clara, cronológica y coherente dificulta:

- Verificar pertinencia, oportunidad y continuidad de la atención.
- Sustentar el pago de los servicios ante el pagador.
- Acreditar la calidad del servicio prestado.
- Cumplir con estándares de habilitación, certificación o acreditación.

Esto puede dar lugar a hallazgos adversos en auditorías, afectación de indicadores de gestión, y pérdida de confianza en el sistema.

Conclusión Técnica y Argumentada

La historia clínica en Colombia constituye un instrumento vital que trasciende lo clínico para integrarse a las esferas jurídica, financiera y ética del sistema de salud. Su adecuada elaboración garantiza la transparencia del proceso asistencial, la correcta facturación de los servicios, la sostenibilidad económica de las IPS, y la protección de los derechos de los pacientes.

Cualquier inconsistencia, omisión o alteración en la historia clínica compromete no solo la legitimidad del servicio prestado, sino también la integridad institucional, la legalidad del cobro y la viabilidad del sistema de aseguramiento en salud. En un entorno regulado y vigilado, donde el uso indebido de recursos públicos se sanciona con rigor, la historia clínica se convierte en el **testigo técnico y legal** que valida o invalida toda la cadena de atención.

Por lo tanto, invertir en la formación del talento humano, en sistemas de información interoperables, y en una cultura organizacional basada en la ética documental, es la única vía para garantizar la **calidad asistencial, la legalidad financiera y el respeto por la dignidad del usuario.**